

DOCUMENTO 6

[Informe sobre la investigación administrativa realizada en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas – Hospital Central de las Fuerzas Armadas].¹

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Informe Investigación administrativa sobre el
destino de las Historias Clínicas de los detenidos
políticos en el período 1/1/1968 – 28/2/1985

Montevideo, 7 de mayo de 2010

Sr. Ministro de Defensa Nacional

Luis Rosadilla

Cúmpleme remitir a Ud. el presente informe y las actuaciones tramitadas en expediente 2009.05734-2 y su acordonado 2010.00555-0, de conformidad con lo dispuesto por el art. 215 del Decreto 500/991, elaborado en base a las conclusiones arribadas luego de culminada la Instrucción de la Investigación Administrativa y su prórroga dispuestas por Resoluciones MDN N° 57.533 del 24 de diciembre de 2009 y N° 57.751 del 9 de marzo del corriente año, según se desarrolla a continuación:

I.- Relación de pruebas diligenciadas en las mencionadas actuaciones:

- 1.- Por Resolución Nro. 57.533 se dispuso la realización de una investigación administrativa en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas – Hospital Central de las Fuerzas Armadas, tendiente a averiguar el destino de las Historias Clínicas de los detenidos políticos que en el período comprendido entre el 1° de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985, fueron asistidos en dicho nosocomio, así como determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente y la individualización de los responsables.
- 2.- Dado el tenor de los hechos a investigar, alejados en el tiempo y tendiente básicamente a averiguar el estado de documentos públicos – para lo cual se necesitaba una reconstrucción histórica – se procedió en primera instancia a notificar al Director

¹ Archivo de la Secretaria de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Fs. 1 a 281.

Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (según obra a fs. 6) y además a solicitarle informes sobre los responsables de la dependencia entre las mencionadas fechas, así como del Hospital Central, de los archivos y específicamente, sobre la conservación y destino de las Historias Clínicas (fs. 8).

3.- Asimismo [...] se solicitó a una funcionaria de profesión Archivóloga, un informe técnico – cuyo tenor surge de fs. 28 – respecto a las Historias Clínicas existentes en la Dirección Nacional de Sanidad y específicamente respecto de las que constituyen el objeto de la investigación. Ello obedeció a la necesidad de efectuar un relevamiento y análisis técnico en el propio lugar físico donde obran las historias.

4.- Además, la suscrita instructora comprobó personalmente el estado de conservación de dichos documentos y los lugares donde están ubicados, según acta que obra a fs. 32.

5.- Respecto a la prueba testimonial, se recabaron los testimonios de aquellas personas que revistaron como Directores Nacionales de Sanidad en la época y en un período reciente – dadas las declaraciones de uno de los testigos, lo cual se desarrollará infra-; también de las personas que ejercieron como Directores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y quienes fueron Sub Directores Técnicos en el lapso 1968-1985 (declaraciones obrantes a fs. 49, 75 a 80, 156 y 157, 162 a 165, 181 a 190, 193 a 194, 236 a 237 y 239 a 240).

Cabe mencionar las situaciones de los testigos: José Martín cuyo domicilio no pudo ser ubicado – según constancias de fs. 39, 42, 50 y solicitud de citación al Ministerio del Interior de fs. 82, 158; Hunaldo Scasso que por su estado de salud la suscrita entendió que no estaba en condiciones de declarar, [...] y Luis Oronoz cuya citación fue solicitada al Ministerio del Interior según surge de fs. 195 [...] a través de los cuales se da cuenta que el testigo habría fallecido.

6.- Por último obra de fs. 91 a 141 el informe técnico efectuado por la Arch. Liliana Gargiulo y la ampliación del mismo luce de fs. 198 a 222. [...].

II- Evaluación de la prueba referida. Irregularidades detectadas.

1.- Como puede verse a la luz de la diversa prueba recabada en las actuaciones, se han producido contradicciones y diferencias en los testimonios lo cual dificulta la reconstrucción de los hechos tendiente a saber con certeza el destino de las Historias Clínicas objeto de la Investigación. Debido a ello, se referirá en una primera instancia a los documentos remitidos por la Dirección Nacional de Sanidad de los que surge una

forma de organizar el archivo de las mencionadas Historias, comparándolos con el desarrollo de las circunstancias tal cual las recuerdan los testigos.

Cabe efectuar la aclaración, si bien resulta obvio, que si las Historias Clínicas buscadas hubieran sido conservadas de acuerdo a cómo lo eran el resto de las Historias, se ubicarían con facilidad y no se debería haber efectuado una investigación para tratar de hallarlas.

O sea, esta investigación parte de una situación irregular según se manifiesta en los Resultando I) y II) de la Resolución, por lo que se tratará en lo posible, de reconstruir circunstancias tendientes a establecer los hechos y sus responsables, de acuerdo a la prueba recabada.

2.- A fs. 12 obra el listado de los Directores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en el período objeto de la investigación y a fs. 20 el listado de los Directores Nacionales de Sanidad en el mismo período.

De fs. 22 a 24 surge la solicitud remitida al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas a los efectos de que informen domicilios de las personas que revistaron en tales cargos, así como se establezca quiénes hubieren fallecidos. Dicho pedido de informes fue contestado según obra a fs. 25, del cual se tomaron los nombres y domicilios de las personas a ser citadas en calidad de testigos.

No obstante, de la mencionada información proporcionada por la Dirección de Sanidad, llama la atención que no se mencionen los nombres de los Responsables de los Registros Médicos o del Archivo que revistaron en la época objeto de la investigación, máxime que a fs. 13 se menciona el nombre de “Raquel Martinelli Labadies” como encargada de la Jefatura de Archivos Médicos entre los años 1972 a 1975, sin relacionar los nombres de las personas que la antecedieron ni los que la sucedieron.

Más aún cuando del mismo informe surge que por orden del propio Hospital en el mes de marzo de 1972 se creó el Departamento de Registros Médicos – actualmente denominado Departamento de Archivo y Registros Médicos – el cual tenía entre sus cometidos: “(...) *La sección archivo se encarga de custodiar y preservar las Historias Clínicas. Lleva además el control de movimientos de Historias Clínicas: quién retira, cuándo es devuelta y cuándo es guardada (...)*” Va de suyo, por el propio sistema administrativo interno de la época, que las designaciones de los Jefes de Departamento – en este caso el de Registros Médicos – se efectuaban por Resolución u orden de los Directores de Sanidad, del Hospital o quien fuera competente; de lo cual debe existir registro escrito como lo hubo de la Sra. Martinelli (según emana de fs. 15). El brindar

información de forma incompleta (por dichos registros así como la documentación faltante que puede inferirse del recaudo obrante a fs. 16) también constituye una irregularidad que consiste en no brindar la colaboración debida con la investigación administrativa que se desarrolla.

No obstante lo dicho, de la documentación puede extraerse como conclusiones que estaba prevista la existencia de un Departamento de Registros Médicos – constituido como tal desde marzo del año 1972 – al cual le competía el “Registro General de Pacientes” [...].

Dicho archivo dependía directamente de la Sub Dirección Técnica y en esa época estuvo como Jefa del mismo y encargada de su organización, la Sra. Martinelli (fs. 16). [...]

Como surge de la nota parcial que obra a fs. 16, la información que el Sub Director elevaba respecto al tema registros era dirigida al Director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que en el año 1974 fue el fallecido Cnel. Arturo Sasso.

Cabe asimismo mencionar, que en el pedido efectuado por la suscrita al Director Nacional de Sanidad – luce a fs. 8 – en el último literal se solicita información actual respecto de la conservación y destino de las Historias Clínicas en el período de referencia, emergiendo del informe de fs. 13 que *“(...) no se dispone de ninguna otra información referente al registro de Historias Clínicas en el período en cuestión.”* O sea, que no se reconoce ninguna excepción dentro del régimen general referido de tratamiento de Historias. Esto – sin más – podría llevar a una primera conclusión respecto a que las Historias en cuestión habrían seguido el mismo destino que las demás iniciadas en la época, debiendo permanecer archivadas en el mismo sitio que las de los usuarios del Hospital.

3.- Vista entonces tal información proporcionada por la Dirección Nacional de Sanidad, la suscrita instructora se trasladó al lugar donde está situado el Departamento de Registros y Archivos Médicos, constatando lo que está reseñado en acta de fs. 32 y 32 vto. De la misma se destaca el hecho de que físicamente están separados los Archivos Activo y Pasivo, según se trate de Historias Clínicas de personas que se atiendan actualmente en el Hospital – incluido los niños – y aquellas Historias que pertenezcan a fallecidos y a quienes durante 10 años no realizaron consultas. Las Historias cuentan con numeración correlativa, con la excepción de las referidas a niños que llevan un sistema de numeración diferente. En la visita no se manifestó en ningún momento por

parte de los funcionarios allí presentes ni del Director Nacional, que se hubiera previsto o llevado a cabo algún procedimiento de destrucción de Historias.

4.- Las declaraciones testimoniales de los jefes que tuvieron responsabilidad sobre la materia objeto de la investigación resultan coincidentes en dos aspectos: primero, que a los detenidos y a las detenidas políticas en la época de referencia que eran ingresados al Hospital se les confeccionaba Historia Clínica. No hubo manifestaciones por parte de los declarantes en contrario, sino solamente expresan no tener conocimiento o no recordar, los testigos Coitiño a fs. 49 y Maccio a fs. 162 vto., además de los Directores de Sanidad en el período democrático (fs. 181 en adelante).

Segundo, que ningún testigo reconoce que se hubieran efectuado destrucción de las Historias clínicas, ni el período de referencia [...] ni en el lapso que cumplieron funciones los Directores de Sanidad posteriores.

En conclusión, está absolutamente probada la existencia de las Historias Clínicas de aquellas personas que siendo detenidas políticas se atendieron en el Hospital en el período de referencia.

5.- Surgen las divergencias en las declaraciones en cuanto a la forma de registro y de conservación de las Historias.

En tal sentido la testigo Martinelli, que es Licenciada en Registros Médicos, resulta sumamente ilustrativa. Manifiesta en su declaración que: “(...) *en el año 1972 comenzamos a registrar a todos los pacientes del hospital con el nuevo sistema (...)*” (fs. 75 vto.); “(...) *Todo lo que esté relacionado a un acto médico debe quedar registrado en la historia clínica, que es un formulario que debe constar todo lo que haga el médico y debe quedar registrado y firmado por el médico (...) Luego que le dan el alta, la historia se ordena en la carpeta y se lleva al archivo y se pone en orden numérico (...)*” (Fs. 76). Cuando le fue preguntado sobre, si a nivel nacional o internacional existían en la época normas que regularan el registro, archivo y eventual destrucción de historias o registros médicos, respondió: “*Desde el punto de vista médico había sí un concepto de hasta cuándo se podían mantener las historias clínicas, como eran fuentes de estudios debían mantenerse. Había un vacío legal desde el punto de vista del país, no estaba legislado cuándo podían destruirse, entonces se dio que las historias clínicas de los hospitales públicos no podían destruirse porque eran documentos públicos, (...). En el hospital no se destruían historias.*” (fs. 76).

Esta testigo que es la que ilustra sobre la existencia de libros índices numéricos de Historias Clínicas (a fs. 76 vto.), referidos a posteriori en el informe de la Archivóloga.

Además, acota el sistema de registro de los niños nacidos en el Hospital (fs. 76 vto.), si bien aclara que nunca supo que hubiera nacido un hijo de personas detenidas políticas (fs. 77).

Respecto de las Historias Clínicas buscadas, es esta testigo quien marca una diferencia en cuanto a su registro: Establece que a la “Sala 8” ingresaban las personas detenidas, si bien la testigo nunca entró a esa Sala porque solamente lo hacían las personas autorizadas. Agrega al respecto: *“(…) en el único momento que yo vi detenidos era porque venía con la guardia y con un overol gris y alguna vez vi cuando venía al servicio de radiología. Nos daban el nombre del detenido para ponerle a un boleto de pedidos de rayos, pero nosotros no le poníamos número de historias clínicas, nosotros no nos encargábamos de nada, no lo poníamos en el índice alfabético ni numérico ni apertura o archivo de documentación. No habríamos historias de detenidos políticos, no quedaba archivada ni la historia ni la documentación referida (placas, análisis) ni procedimientos quirúrgicos que se le hubieran realizado. Supongo que tendrían un archivo en la propia sala (…)”* (fs. 77).

La testigo en su declaración está claramente diferenciando dos sistemas dentro del Hospital, el sistema de archivo de Historias de pacientes y el sistema de registro de detenidos políticos. Ella, según sus declaraciones, no tenía intervención en este último, en cuanto según refiere que había personas especialmente autorizadas y un archivo de la propia sala.

Considerando que la testigo prestó servicios hasta el año 1975, se puede afirmar que – por lo menos – hasta ese fecha, el sistema de registro de Historias se mantenía diferenciado – entre usuarios del Hospital y detenidos políticos – y en archivos separados.

Pauta una diferencia el testigo Laitano, que revistó como Director del Hospital en el período 1975-1977, quién preguntado sobre las Historias de los detenidos manifiesta en su declaración: *“(…) los detenidos tendrían que tener sus fichas correspondientes, como un usuario más, no había diferencias de ningún tipo (…).”* (fs. 157).

El testigo Latorre, quien fue Director del Hospital en el período 1977-1978 afirma que las Historias Clínicas referidas se guardaban en el Archivo. Dice en su declaración: *“(…) En el Archivo, se guardaba todo junto, todas las historias clínicas en el mismo lugar. (…)”* (fs. 80). Su declaración marca un cambio en la ubicación de las Historias, que habrían pasado en esa época, de la sala asignada a las personas detenidas políticas, al archivo general.

Asimismo, los testigos médicos que revistaron como Sub-Directores Técnicos del Hospital declaran con diferencias en el régimen de las Historias: el testigo Macció, si bien revistó también en el Hospital Penitenciario de Punta Carretas, no reconoció en el Hospital Militar trato diferente a los detenidos pero no recuerda si se les confeccionaba Historia Clínica (fs. 162-162 vto.); el testigo Boix reconoció que la atención era diferente en cuanto había “(...) *médicos especiales designados por la Sub Dirección Administrativa (...). En la Sala había guardia armada en posición de combate (...) no dejaban entrar a nadie, había gente designada para atender a esos pacientes (...)*” (fs. 163-163 vto.). Respecto de las Historias Clínicas este testigo manifestó: “(...) *Las historias clínicas eran iguales a las de los soldados pero se archivaban en diferente lugar (...). En el Archivo de Historias Clínicas no se archivaban las historias de los detenidos, aunque los médicos hacían las historias clínicas igual que las de otros pacientes (...). Mientras estaban internados las historias clínicas estaban en la sala (...). Las historias clínicas de los detenidos tenían otra numeración, eran por separado (...)*” (fs. 164). El testigo Morse a su vez manifiesta que las Historias Clínicas estaban en un solo lugar (fs. 193 vto.) y agrega: “(...) *Registros Médicos donde estaban las Historias Clínicas estaba a cargo de los militares (...)*” (fs. 194). y el testigo Rinaldi expresa una variante: “(...) *cuando el enfermo es retirado del Hospital, las historias clínicas de los detenidos se llevaban al Archivo. La historia queda donde está el enfermo hasta que se le da el alta y ahí se lleva al archivo general (...)*”. (fs. 239 vto).

La declaración del testigo Rinaldi representa una explicación lógica de la ubicación de las Historias en la época, además de sintetizar las dos eventuales posiciones que surgen de las demás declaraciones: los documentos permanecerían en la Sala especial para detenidos/as mientras permanecieran internados. Una vez de alta, eran llevadas al archivo general.

El testigo Rigoli, que Director del Hospital desde 1984 a 1988 es el único que manifiesta un destino diferente de las Historias Clínicas objeto de la investigación, luego de transcurrido el período dictatorial. En primer lugar, manifiesta la existencia de una orden específica respecto de que “(...) *no se guardaran los nombres de los profesionales y funcionarios que atendían a los detenidos para que luego no se tomaran represalias contra ellos (...)*” Lo dicho por el testigo constituye una irregularidad, según disposiciones de la época que se referirá infra.

En segundo lugar, manifiesta que las Historias se guardaban en la “*Sala de los detenidos*”, lo cual podría significar una coincidencia con la conclusión referida supra.

Afirma, además, que tales Historias no estaban dentro del “(...) *régimen general del Hospital* (...)” y que no eran manejadas por el personal del Archivo (fs. 78 vto.).

La variante más importante es cuando refiere a que la Sala destinada a los detenidos políticos se transformó en el año 1985 y que las Historias objeto de la investigación fueron llevadas a Sanidad, al “(...) *edificio que está al lado del Hospital por 8 de Octubre* (...)” (fs.79). Según el testigo, el Director de Sanidad de la época era el Cnel. Goldaracena, ya fallecido. La circunstancia de que el Cnel. Goldaracena revistara como Director Nacional de Sanidad emerge asimismo del informe de fs. 20 y su fallecimiento del informe de fs. 25. Siguiendo la declaración del testigo, se perdería el rastro de las Historias en mérito del fallecimiento de quien – según su declaración – las habría recibido.

No obstante ello, la información brindada por el testigo es la que dio lugar a la citación de los Directores Nacionales de Sanidad que cumplieron funciones a posteriori del fallecido Cnel. Goldaracena a efectos de poder corroborar o descartar la versión. Esto es, si la mencionada información fuera veraz, a lo cual se suma que los documentos no habrían sido destruidos, permanecerían en el edificio de dicha Dirección; siempre y cuando el Cnel. Goldaracena no hubiera decidido reintegrarlos al archivo general, hipótesis que podría considerarse.

Siguiendo con esta línea, ninguno de los Directores que sucedieron al fallecido Goldaracena y que fueron citados manifiestan saber el destino de las Historias; además niegan que se encontraran en el edificio de la Dirección Nacional de Sanidad en el período en el que prestaron funciones.

En tal sentido obran las declaraciones de los testigos Bértola (fs. 181 – 181 vto.), García (“(...) *nunca tuve conocimiento que se guardara en algún lugar separado* (...)” fs. 183 vto.), Mermot (“(...) *No había archivos separados, todo estaba centralizado en Registros Médicos* (...)” fs. 185), Abilleira (fs. 187 vto.).

En conclusión, de las declaraciones testimoniales resulta más ajustada la hipótesis referida supra, esto es, que las Historias Clínicas se guardaran en la Sala o Salas destinadas a las personas detenidas. Cuando se daba de alta, eran llevadas al Archivo General. Ahí comienza la incógnita sobre lo declarado por el testigo Rígoli acerca de su destino final en la Dirección Nacional de Sanidad, dado que no fue reafirmado por ningún otro testimonio.

6.- Cabe referirse en esta instancia al informe efectuado por la Archivóloga el cual clarifica técnicamente la situación, además de corroborar la probabilidad de la hipótesis esgrimida. Al respecto caben las siguientes consideraciones:

a.- En primer lugar destaca que el Archivo Clínico está conformado por un Archivo de Historias Activas y uno de Historias Pasivas; dentro de este último la fecha límite de las Historias Clínicas data del año 1970, sin perjuicio de que encontró documentos correspondientes a los años 1968 y 1969 (fs. 92). Refiere a los libros índices donde se registra el número correlativo de la Historia Clínica; correspondiendo al período de la investigación los numerados del 1º al 20º. Asimismo, los números de las Historias Clínicas correspondientes a dicho período alcanzan del 100.000 al 331.891, entre otros detalles (fs. 93).

b.- Dentro de las conclusiones a las cuales arribó, se destacan las siguientes: *“Las historias clínicas se llevaban en las Salas y allí se conservaban y posteriormente se forma el archivo clínico. El archivo pasivo no siempre estuvo ubicado en el lugar donde se encuentra hoy día. Existieron historias clínicas anteriores a 1970. No se puede determinar si estas fueron destruidas o por sufrir distintos cambios edilicios se perdieron a través de los años. (...) Debido a la existencia de 20 libros índices de historias clínicas correspondientes al período de investigación, indicando solamente nombres y apellidos resulta imposible poder identificar y adjuntar relación de los funcionarios, familiares, detenidos políticos o hijos de los mismos. Se deberá revisar libro por libro y nombre por nombre para verificar los diferentes Usuarios/pacientes. (En esta etapa fue imposible efectuar listado diferenciado) (...)”* (fs. 96).

En mérito de tales conclusiones, se dispuso que la citada profesional ampliara su informe en los términos que lucen en acta obrante a fs. 151.

c.- En tal sentido se agrega informe ampliatorio que luce a fs. 198 y siguientes, destacándose el hallazgo de una Historia Clínica perteneciente a un detenido político, referida en acta que luce a fs. 200. Dicha Historia identificada con el número 142.788, luce en su carátula: “Civil Det.” Y su fotocopia obra agregada de fs. 201 a 219. Como fue registrado en el acta, en el fs. 203 luce la palabra *“Detenido”*.

d.- Sin perjuicio de la importancia del referido hallazgo, se destacarán los demás elementos principales del informe: en primer término, encontró anomalías en los libros de registro de Historias en las cuales refiere a fs. 198 y 199, además del acta de fs. 200. En segundo lugar explica el muestreo efectuado a través del cual pudo encontrarse la Historia mencionada [...]

e.- Como fuera dicho supra, siguiendo al sugerencia del informe de la citada profesional, se remitió al Archivo General de la Nación solicitud de información sobre el titular de la Historia Clínica encontrada – para verificar la calidad de detenido político – así como requerir Historias Clínicas de personas detenidas que pudieran obrar en el referido Archivo.

La información brindada por ese organismo ratifica la condición de detenido político del titular de la Historia, [...].

f.- Del primer informe elaborado por la Archivóloga emergen las normas referentes a las Historias Clínicas que reconoce como rectoras en la materia, así como sobre los derechos de paciente, obligaciones de las instituciones de asistencia y de los médicos (fs.104 a 141).

No obstante, del análisis de dicha normativa se destaca especialmente la ausencia de reglas específicas que establezcan pautas en la época de referencia, relativas a las Historias Clínicas de todas las instituciones de asistencia. Tampoco fue aportada información por la Dirección de Sanidad en su momento.

Lo más cercano a ello obra a fs. 106, que constituye una Ordenanza del Ministerio de Salud Pública que data del año 1954, numerada con el 363/54 que establece la obligatoriedad de que cada enfermo tenga su historia clínica (art. 1º). [...]. Del art. 8º resultan las responsabilidades que corresponden a los jerarcas. Dice dicho art.: “(...) *La existencia de la historia clínica en la forma establecida en la presente ordenanza es responsabilidad, en orden jerárquico y/o jurisdiccional ascendente, del médico tratante [...] del Jefe del Servicio clínico y de la dirección del establecimiento.*”

De acuerdo con lo emerge del precitado informe, en la época objeto de la investigación estaba vigente dicha Ordenanza, que si bien resulta una norma del ámbito interno del Ministerio de Salud Público, puede tomarse como un elemento indiciario para establecer parámetros en la confección de Historias, sus elementos, así como las responsabilidades de los médicos y jerarcas; máxime cuando en el organismo al cual pertenece el propio servicio médico de referencia (Ministerio de Defensa Nacional) no se habían emitido reglas al respecto.

Es más, surgen de lo declarado por la testigo Martinelli similares criterios para el tratamiento de las Historias ene. Hospital que los establecidos n la menciona ordenanza. La propia testigo manifiesta que a nivel internacional habían pautas para el manejo de las historias, pero “...había un vacío legal desde el punto de vista del país, no estaba

legislado cuando podían destruirse porque eran documentos públicos (...) En el hospital no se destruían las historias...” (fs. 76).

La reglamentación referente a la destrucción de Historias provino recién en 1982 por Decreto N° 355/982 (fs. 108-109). Pero si bien en una primera instancia parece acotada al ámbito del Ministerio de Salud Pública, el “DECRETA” lo hace extensivo a otras instituciones de asistencia médica. Se cita al respecto: *“VISTO: la necesidad de proceder al dictado de normas que regulan el procedimiento a seguir para la destrucción de ciertos documentos que estando en poder del Ministerio de Salud Pública han cumplido ya con la finalidad para la cual se lo remitió al mismo y cuya eliminación no está prevista en forma expresa” (...)*

“DECRETA: (...) Las distintas instituciones de asistencia médica –sean éstas públicas o privadas- podrán proceder a la destrucción de las historias clínicas de los pacientes en ellas atendidos cuando se den las condiciones exigidas por el presente decreto”.

Por ende, el Decreto citado regula un procedimiento para la destrucción de las historias, de acuerdo a la antigüedad (tres o cinco años) que las mismas tengan en los Archivos Pasivos, cumpliéndose determinadas condiciones.

La interpretación de esa norma pudo implicar en su momento que se procediera a la destrucción de las Historias que cumplieran con los requisitos que emanaban de sus disposiciones. No obstante, según las declaraciones de todos los testigos no se procedió a la destrucción de ninguna. Esto es, la mencionada norma no fue aplicada en la Dirección de Sanidad. Constituye otra prueba de ello el Archivo Pasivo que cuenta con Historias de más de 30 años y sus libros de registro respectivos.

Dicha norma recién fue modificada por el Decreto 37/005 del 27 de enero de 2005 (obra a fs. 139) que torna más restrictivas las posibilidades de destrucción de la documentación.

Las demás normas mencionadas en el informe resultan posteriores o de temáticas diversas a lo establecido para la presente investigación.

f.- En síntesis, de lo informado por la Arch. Gargiulo pueden extraerse varias conclusiones:

En primer término, que no han sido encontradas en el Archivo Pasivo un conjunto de Historias Clínicas cuyo titulares sean personas detenidas políticas o identificadas por ese carácter. Esto es, no se individualizan las Historias objeto de la investigación como un cúmulo de documentación señalada como tal –como refiere el testigo Rígoli al manifestar que entregó “las Historias” en la Dirección de Sanidad-.

En segundo término, que del muestreo muy parcial efectuado por la Archivóloga – obviamente por se escaso el tiempo para analizar enormes cantidades de Historias- pudo detectarse una de las requeridas. Eso puede indicar que efectuando un trabajo de investigación minucioso en el Archivo Pasivo, además de poder contar con un listado de los nombres de las Historias a buscar para facilitar la tarea, pueda existir la posibilidad de efectuar más hallazgos.

En tercer término, que la historia encontrada se diferencia de las demás, lo cual se nota en su propia carátula. De una sola no puede extraerse la conclusión de que todas las historias buscadas estén identificadas como “Civil Det.” en su carátula, pero es un indicio más para encauzar la búsqueda. Haciendo la salvedad además, destacada en el acta de fs. 200, que en el libro en que figuraba registrada había numerosas irregularidades, que pueden tomarse como punto de partida de un trabajo de investigación exhaustivo.

En cuarto término, llama la atención que la Historia haya sido numerada, lo cual introduce dentro del régimen “común” de registro de usuarios. Con la salvedad d que no se ha podido detectar por la Archivóloga que hubiera números especialmente destinados a detenidos políticos, hipótesis que cuenta con el solo sustento de la declaración del testigos Boix, supra señalada; por lo que podrían configurar un punto de partida de la investigación ya sugerida.

III.- Conclusiones de la presente investigación:

1.- Las irregularidades que fueron detectadas como manifestara supra, emergen del propio hecho que dio inicio a la investigación: “...cada vez que se solicita la Historia Clínica de un detenido político internado en su momento en dicho Hospital, la misma no es encontrada...” (Resolución MDN 57.533)

En la presente investigación se trató de dar respuesta a ello, llegando a la conclusión de que no existe ningún indicio acerca de que haya habido destrucción de Historias clínicas. Ni de las pertenecientes a los usuarios ni las de personas detenidas políticas.

Por lo cual cabe la presunción de que las Historias están y hay que localizarlas, más aún cuando se efectuó la búsqueda en el Archivo Pasivo a raíz de la presente investigación, se pudo localizar todas las Historias.

No se configuró un sistema de búsqueda exhaustiva cada vez que se solicitaba una Historia de personas detenidas y tampoco se organizaron procedimientos de investigación interna tendientes a ubicarlas en su conjunto y colaborar así con la política

del Estado en materia de Derechos Humanos aplicada a partir del 2005, lo cual se manifestó en un interés público en la materia (artículo 9º del Decreto N° 30/003 del 23 de enero de 2003)

Dicha irregularidad abarca también el hecho de omitir o negar información (según fuera detallado supra) y resulta contrario a lo dispuesto en el lit. A del art. 12 del Decreto mencionado y hace incurrir en las responsabilidades previstas en el art. 31 de la Ley 18.381 (“Derecho de Acceso a la Información Pública”).

Desde el primer pedido de búsqueda de Historias de personas detenidas al presente –si bien no consta en qué fecha se iniciaron las solicitudes, resulta previsible que fueron a partir de 2005-, la propia Dirección debió implementar un mecanismo de clasificación y búsqueda tendiente a mejorar la situación de organización y conservación de la documentación y su fácil acceso, que por lo que surge de las fotos obrantes a fs. 99, sumado a lo que pudo corroborar la suscrita instructora en el lugar, es claramente deficitario.

Por lo cual, esta instructora más que tratar de señalar responsabilidades individuales que podrían alcanzar a los ex funcionarios declarantes, demás responsables administrativos y militares de la época objeto de la investigación, así como de todos los Jerarcas vinculados al sistema de Registro y Archivo dentro del servicio –o sea, los Jerarcas en el sentido señalado por la Ordenanza 363/954 del MSP-, entiende que resulta afín a los objetivos señalados en la presente investigación y dado sus resultados en la aparición de una Historia, sugerir medidas a tomar para evitar que se reiteren las situaciones irregulares en el manejo de la documentación –según lo dispone el art. 215 del Decreto 500/991- y tendientes además a identificar las Historias de personas detenidas políticas que –según la prueba recabada- aún permanecerían en los archivos del Hospital.

En tal sentido también se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18.331 referida a la protección de datos personales y acción de “Habeas Data” (arts. 4º lit. E, 10, 12, 14, 19 y 25)

Para ello sugiero la conformación de un equipo técnico encabezado por la Archivóloga que efectuó los informes, el cual deberá comenzar un trabajo de búsqueda, selección, clasificación –en principio dentro del Archivo Pasivo-, a los efectos de culminar con el trabajo iniciado en la presente investigación.

Asimismo, podrá presentar un proyecto para solucionar la problemática detectada en el Archivo Activo que resulte beneficioso para el servicio y la atención del usuario.

De esa forma se seguirían las directrices establecidas en el art. 6º de la Ley 18.361 “Derecho de acceso a la información pública”.

2.- Por último cabe agregar la posibilidad de que una vez implementado el sistema de búsqueda y organización sugerido, no sean encontradas más Historias; situación que implicaría por la vía de los hechos desvirtuar las conclusiones de la presente investigación en cuanto la prueba recabada apunta a que la documentación requerida no fue destruida.

Esto es, en caso de no ser localizadas en los Archivos las Historias buscadas, podrían configurarse presuntos delitos; por lo que de producirse, se deberá dar cuenta a la Justicia competente; según lo preceptuado en el art. 177 del Código Penal en la redacción dada por el art. 8º de la Ley 17.060 y art 41 del Decreto 30/003.

IV.- Expedientes remitidos con solicitud de Historia Clínica:

En mérito de la investigación que se llevó a cabo fueron remitidos a esta instructora los expedientes que detallo a continuación: 2010.02583-7 (Juan Miguel García), 2009.03391.5 (Roberto Caballero), 2010.00930-0 (Héctor Pérez), 2010.01123-2 (Blanco, Ana- Blanco, Bernardo), 2010.01122-4 (Blanco, Ana- Luzardo, Luis).

Dichos expedientes tienen en común que sus titulares se presentaron peticionando historias clínicas de personas que en su momento fueron detenidos políticos atendidos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

En todos ellos obra informe de la Dirección Nacional de Sanidad en el cual se establece que no existe registro de la Historia Clínica solicitada.

En la presente investigación como fuera dicho se ha encontrado solo una Historia Clínica, la cual no se corresponde con ninguna de las solicitudes referidas.

En virtud de lo cual sugiero, que sean notificados los peticionantes acerca de que en la presente investigación no han sido localizadas las Historias requeridas, quedando a criterio del Sr. Ministro iniciar las instancias posteriores sugeridas por la suscrita tendientes a proseguir la búsqueda.

IV.- De conformidad con lo informado la suscrita instructora sugiere al Sr. Ministro que:

1. Se remitan las actuaciones al Fiscal de Gobierno de Turno en mérito a la interpretación de lo dispuesto por el art. 218 del Decreto 500/991, que prevé que cuando el instructor sea el Asesor Jefe deberán enviarse las actuaciones a dicho Fiscal por

informe letrado. en las presentes circunstancias, dada la potestad de supervisión jurídica que la suscrita tiene sobre las Asesorías Letradas (Resolución MDN 54.164 del 15 de febrero de 2007), además de su función como Directora General, se estaría más que en la hipótesis prevista en dicha disposición, pues según lo expuesto, existe un vínculo jerárquico sobre dichas dependencias. Por lo cual, también aporta a la transparencia de la gestión el hecho de remitir la presente investigación a la Fiscalía de Gobierno.

2. En definitiva y una vez culminada la tramitación correspondiente, se tomen las medidas sugeridas en el presente informe, en caso que el Sr. Ministro lo considere pertinente.

Sin otro particular, saluda atentamente.

[Firma]

Dra. Gabriela González

Directora General de Servicios Sociales

Ministerio de Defensa Nacional
Montevideo, 18 de mayo de 2010

Sra. Fiscal de Gobierno de 2do. Turno

Remito a usted las presentes actuaciones tramitadas a raíz de la investigación administrativa dispuesta por Resolución N° 57.533 del 24 de diciembre de 2009 a efectos de recabar su opinión, de acuerdo a lo sugerido por la Instructora actuante y según lo dispuesto en el artículo 218 del Decreto 500/991.

Saluda atentamente

Luis Rosadilla [Firma]
Ministro

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de Servicios Sociales

Montevideo, 21 de mayo de 2010

En el día de la fecha se procede a acordonar al presente, el expediente MDN Nro. 2010.005.55-0

Cbo. 2da. (MDN)
Daniela Bermúdez [Firma]

Fiscalía de Gobierno de 2° Turno

Exp. N° 197/2010.- Dict. N° 218/T/2010.-

Proyecto: Dra. Miriam Areosa.- m.g./pot.

Sr. Ministro:

Por resolución de esa Secretaría de Estado de 24/12/2009 (fs. 4), se dispuso la realización de una investigación administrativa en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, tendiente a averiguar el destino de las Historias Clínicas de los detenidos políticos en el período comprendido entre el 1/1/968 y el 28/2/985 que fueron asistidos en aquel nosocomio, así como determinar o comprobar hechos u actos irregulares que afecten a ese servicio.-

Formalmente, cabe señalar que la investigación se instruyó con ajuste a los plazos reglamentarios, prorrogándose el plazo por resolución de 9/3/2010 (fs.7).-

Se realizaron además, las diligencias necesarias para esclarecer la situación investigada.-

En lo sustancial, y en el análisis de la prueba recogida, se comparten las conclusiones a que arribara la instructora de fs. 262 a 271, por lo que se dirá.-

La comprobación de existencia, inexistencia, ubicación actual, y o destino final de las historias clínicas de los detenidos políticos que fueron asistidos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en un período que finiquitó hace ya veinticinco años (al 28/2/10), requiere de una indagación más profunda y exhaustiva que la que puede realizarse en el exiguo término 4 meses.-

El paso del tiempo incide inexorablemente sobre los seres y las cosas, diluyendo y/o dispersando la prueba de los hechos que se intentan acreditar.-

Este principio no escapa a la investigación ordenada en obrados: testigos fallecidos (fs. 25 y 223-224), otros enfermos (fs. 86), traslado de instalaciones (fs. 79), etc..-

La presente investigación cumple estrictamente lo ordenado, conforme al plazo otorgado, y las conclusiones a las que se arriba con su consecuencia directa.-

Solo con una investigación como la aconsejada a fs. 270, se podrá obtener resultados más ajustados a la verdad material de los hechos indagados.-

Ahora; surge de la prueba testimonial (fs. 49, 76, 78 y vta., 80 y vta., 164, 194 y 239 vta.), que a los detenidos políticos atendidos en el Hospital de la F.F.A.A., se les realizó historia clínica como a cualquier paciente.-

Asimismo, estos testimonios afirman no tener conocimiento de que se hubiere realizado destrucción de las Historias Clínicas referidas.-

De los informes realizados por la Archivóloga Gargiulo (fs. 91 y sgs; 198 y 221) es de destacar no solo la carencia de tiempo para verificar la existencia de las historias clínicas en los 20 libros índices, y el hallazgo –dentro de un muestreo aleatorio y cronológico- de una Historia Clínica perteneciente a detenido político (fs. 2009.-

Este descubrimiento dentro del muestreo podrían indicar la existencia de otras historias dentro del Archivo General.-

La excepción a que las fichas clínicas de los detenidos no fueron llevadas al archivo general, es la del testigo Rigoli, quien manifiesta que estas historias fueron llevadas a Sanidad, siendo el Director en esa época el Crel. Goldaracena, ya fallecido.-

Esta Fiscalía considera que con la presente investigación se ha llegado a una primera y probable conclusión: la existencia de las Historias Clínicas de los detenidos políticos dentro del deficitario Archivo General.-

Sin embargo, aquella deberá funcionar como una hipótesis de trabajo para arribar a una conclusión certera y definitiva, que podrá confirmarla o rechazarla.-

En esta línea se aconseja, proceder como se sugiere a fs. 270 destinando para ello recursos materiales y humanos para que la misma pueda concluirse en un plazo prudencial (que podría ser seis meses).-

Debe señalarse, que si bien ya se han presentado personas solicitado historias clínicas de detenidos políticos (fs. 270 vta.), pueden realizarlo más personas y es obligación legal del Responsable de la Base de Datos proporcionar la información, bajo pena sancionatoria (art. 14 y 35 de la ley n° 18.381 de 11/8/2008), lo que amerita una actuación diligente y eficaz.-

En la hipótesis de que no encontraran las historias clínicas –luego de realizada la búsqueda, y clasificación de las historias-, volverá a informe fiscal para pronunciarse sobre el procedimiento a seguir.-

Montevideo, 8 de junio de 2010.-

Dr. Miguel A. Toma Sanchis.- [Firma]

Fiscal de Gobierno de 2° Turno

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Servicios Sociales

Montevideo, 12 de julio de 2010

Director General de Secretaría

Jorge Delgado

Remito a Ud. Las presentes actuaciones tramitadas en mérito a la investigación administrativa y su ampliación dispuestas por Resoluciones MDN 57.533 del 24 de diciembre de 2009 y 57.751 del 9 de marzo de 2010, a los efectos de comunicarle lo dictaminado por el Sr. Fiscal de gobierno (...).

Saluda a Ud. Atentamente

Dra. Gabriela González [firma]

Directora General de Servicios sociales

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría

Montevideo, 01 de julio de 2011.-

Pase Expediente N° 2009.08131-6 a la Secretaria del señor Ministro, a sus efectos.-

La Jefa de Secretaría de la D.G.S.

Tte. 1ro. (MDN)

Angélica Cabara [Firma]